ROTINA CLÍNICA

OSTEOPOROSE

ABORDAGEM PRÁTICA



Diagnóstico, rastreio e tratamento na UBS

O que é osteoporose?

Distúrbio esquelético **crônico e progressivo**

Origem **multifatorial**

Acomete principalmente **idosos**, homens e mulheres

Geralmente **após a menopausa**

Baixa massa óssea + deterioração da microarquitetura

do tecido ósseo

Quem e quando?

6–33%

de prevalência em estudos brasileiros

Grande variação pela mistura étnica, com distribuição regional heterogênea.

POPULAÇÃO DE DESTAQUE

Mulher caucasiana, sobretudo após a menopausa



Imagem: Radiopaedia.org

FRATURA DE **Punho**	**5ª** década de vida
FRATURA **Vertebral**	Aumenta após a **6ª** década
FRATURA DE **Fêmur**	A partir da **7ª** década

Fonte: Tratado de Geriatria e Gerontologia, 5ª ed.

Fatores de risco



1. **Sexo feminino**
2. **Baixa massa óssea**
3. **Fratura prévia**

- Etnia **asiática ou caucásica**
- **Idade** avançada
- **Menopausa precoce** não tratada (antes dos 40 anos)
- Uso de **glicocorticoide**
- **Tabagismo**
- **Baixa massa corpórea** (IMC < 19 kg/m²)

Fonte: Tratado de Geriatria e Gerontologia, 5ª ed.

Quadro clínico ASSINTOMÁTICA até que ocorra uma fratura

EQUÍVOCO COMUM

Muitos pacientes **sem sintomas** presumem, incorretamente, que não têm osteoporose.

EQUÍVOCO COMUM

Muitos pacientes com **desconforto musculoesquelético** atribuem suas queixas à osteoporose.

Fonte: Clinical manifestations, diagnosis, and evaluation of osteoporosis in postmenopausal women – UpToDate.

Diagnóstico

3 critérios

1 CRITÉRIO CLÍNICO

Fratura de fragilidade

Fratura após queda da própria altura ou de uma altura inferior.

2 CRITÉRIO DENSITOMÉTRICO

T-score ≤ −2,5

3 ELEVADO RISCO DE FRATURA (FRAX)

Probabilidade em 10 anos

≥ 20%
fratura osteoporótica maior*

ou

≥ 3%
fratura de quadril

*Quadril, coluna (clínica), úmero proximal ou antebraço.

Fonte: Clinical manifestations, diagnosis, and evaluation of osteoporosis in postmenopausal women – UpToDate.

Interpretação da densitometria

T-score	Interpretação
≤ −2,5	Osteoporose
−1 a −2,5	Baixa massa óssea (osteopenia)
≥ −1	Normal

Detalhamento

T-score: comparação com adultos jovens do mesmo sexo.

Z-score: comparação com população de mesma idade, sexo e etnia.

Quando rastrear?

65
ANOS
Mulheres

70
ANOS
Homens

Densitometria óssea

Ou na presença de fatores de risco:
baixo peso · fratura prévia · medicamentos ou doenças que afetam a saúde óssea

Rastreamento populacional amplo e aleatório não é preconizado
pelo custo relativamente elevado

Referência: PCDT Osteoporose, Ministério da Saúde.

Tratamento é um conjunto

1 Dieta adequada

2 Cálcio + vitamina D

1.000–1.200
mg/dia de cálcio elementar

400–800
UI/dia de vitamina D (colecalciferol)

Cálcio elementar total (dieta + suplemento) **≤ 2.000 mg/dia**
Acima disso: risco de efeitos adversos

3 Atividade física resistida

Contração muscular → formação óssea
Exercício com carga: **≥ 30 min**, na maioria dos dias
Fortalecimento muscular e postura: **2–3x/semana**
Força + equilíbrio → **menos quedas** e fraturas

4 Antirreabsortivos ou anabólicos

Conforme indicação clínica

Fontes: Calcium and vitamin D supplementation in osteoporosis; Overview of the management of low bone mass and osteoporosis in postmenopausal women – UpToDate.

EXEMPLO PRÁTICO • BISFOSFONATO

Alendronato de sódio

70 mg — **1 comprimido por semana**
Sempre no mesmo dia

COMO TOMAR

- Ao levantar, em **jejum**: sem comida, bebida ou remédios
- Com **1 copo cheio de água** filtrada (180–240 mL)
- **Ficar em pé ou sentado ≥ 30 min** e não deitar até a 1ª refeição
- Esperar **≥ 30 min** para comer, beber ou tomar outros remédios (antiácidos, cálcio, vitaminas)
- Não tomar à noite nem antes de se levantar

FUNÇÃO RENAL

ClCr < 35 mL/min:
uso não recomendado

DURAÇÃO

Considerar suspender após **5 anos** se DMO estável, sem fratura prévia e baixo risco (**Drug Holiday**)

Risco alto: até **10 anos** ou trocar medicação

Fontes: Bula Alendronato de Sódio; Alendronate: Drug information – UpToDate.